

Exantema febril en el adulto

Un enfrentamiento por morfología y distribución · Los cuadros que no se pueden perder · Cuándo aislar y cuándo notificar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: VVZ: virus varicela-zóster · VHS: virus herpes simplex · VEB: virus de Epstein-Barr · CMV: citomegalovirus · SSTE/SSTS: síndrome de shock tóxico estreptocócico / estafilocócico · DRESS: *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms* · SSJ/NET: síndrome de Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica · PEGA: pustulosis exantemática generalizada aguda · CID: coagulación intravascular diseminada · PCR: reacción en cadena de la polimerasa · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en la literatura de referencia sobre exantemas febriles y en las guías de las enfermedades específicas (CDC, IDSA), así como en la normativa chilena de vigilancia de sarampión, rubéola, enfermedad meningocócica y otras enfermedades exantemáticas. **El sarampión, la rubéola y la enfermedad meningocócica invasora son de notificación obligatoria inmediata en Chile: verificar el decreto vigente.**

Índice

1. Cómo ordenar el problema
2. Las cuatro preguntas iniciales
3. Los cuadros que no se pueden perder
4. Exantema maculopapular
5. Exantema vesiculoso o ampolloso
6. Exantema petequial o purpúrico
7. Exantema con eritrodermia y descamación
8. Exantema pustuloso
9. Compromiso de palmas y plantas
10. Exantemas por fármacos
11. Estudio diagnóstico
12. Aislamiento y notificación
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Cómo ordenar el problema

El exantema febril es un motivo de consulta frecuente y con un diferencial enorme. Tres ejes ordenan el razonamiento:

1. **¿Está gravemente enfermo?** — la pregunta que se responde primero.
2. **¿Qué morfología tiene la lesión elemental?** — maculopapular, vesiculosa, petequial, pustulosa, eritrodérmica.
3. **¿Cuál es el contexto?** — fármacos, viajes, contactos, exposiciones, vacunación, estado inmune, conductas sexuales.

2. Las cuatro preguntas iniciales

1. **¿Hay signos de gravedad?** Hipotensión, taquicardia, confusión, hipoxemia, oliguria, **púrpura**, **compromiso de mucosas**, **dolor cutáneo desproporcionado**, **signo de Nikolsky** (desprendimiento epidérmico al frotar).
2. **¿Qué fármacos ha recibido en las últimas 8 semanas?** Incluidos los suspendidos, los de venta libre y los suplementos.
3. **¿Cuál es la exposición epidemiológica?** Viajes, contactos con enfermos, animales, picaduras, alimentos, agua, conductas sexuales, ocupación, estado vacunal.
4. **¿Está inmunosuprimido?** Cambia el diferencial y la urgencia.

3. Los cuadros que no se pueden perder

Estos son los diagnósticos cuya demora cuesta vidas u órganos, y deben descartarse activamente en todo exantema febril:

Cuadro	Pistas	Conducta inmediata
Meningococcemia	Petequias y púrpura de progresión rápida, fiebre alta, compromiso del estado general, cefalea, meningismo. Puede evolucionar a púrpura fulminante en horas	Hemocultivos y ceftriaxona INMEDIATA , sin esperar la punción lumbar. Aislamiento de gotitas, notificación inmediata , quimioprofilaxis de contactos
Fasciitis necrotizante	Dolor desproporcionado , edema más allá del eritema, bulas, anestesia cutánea, crepitación, toxicidad sistémica	Cirugía urgente + antibiótico de amplio espectro + clindamicina
Síndrome de shock tóxico (estreptocócico o estafilocócico)	Eritrodermia difusa tipo quemadura solar , hipotensión, falla multiorgánica, descamación tardía	Reanimación, retirar cuerpo extraño o drenar foco, betalactámico más clindamicina , considerar inmunoglobulina
Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica	Compromiso de mucosas (oral, ocular, genital), dolor cutáneo, signo de Nikolsky , desprendimiento epidérmico, fármaco reciente	Suspender el fármaco , derivación a unidad de quemados o dermatología, soporte
DRESS	Exantema extenso, edema facial , fiebre, eosinofilia , adenopatías, compromiso hepático o renal, 2-8 semanas tras el fármaco	Suspender el fármaco, corticoides sistémicos, seguimiento prolongado (riesgo de tiroiditis tardía)
Rickettsiosis	Exantema que puede comprometer palmas y plantas, fiebre, cefalea, antecedente de picadura o exposición. En Chile es infrecuente pero existe	Doxiciclina empírica , sin esperar confirmación
Endocarditis infecciosa	Fiebre prolongada, soplo, lesiones de Janeway, nódulos de Osler, hemorragias en astilla	Hemocultivos, ecocardiograma
Sífilis secundaria	Exantema que compromete palmas y plantas , no pruriginoso, adenopatías generalizadas, condilomas planos	VDRL/RPR y prueba treponémica ; penicilina benzatina
VIH agudo	Exantema maculopapular, úlceras mucosas , fiebre, faringitis, adenopatías	Carga viral de VIH
Sarampión	Fiebre alta, tos, coriza y conjuntivitis , manchas de Koplik , exantema cefalocaudal confluyente	Aislamiento de aerosoles, notificación inmediata , confirmación en el ISP
Varicela grave o diseminada	Vesículas en distintos estadios, compromiso sistémico	Aciclovir; aislamiento de aerosoles y contacto

4. Exantema maculopapular

Es la morfología más frecuente y la de diferencial más amplio.

Causa	Claves
Fármacos	La causa más frecuente en el adulto hospitalizado . Aparece 5-14 días tras iniciar el fármaco (o en horas si hay exposición previa). Predomina en tronco, confluyente, pruriginoso
Virus	VEB, CMV, VIH agudo , parvovirus B19, enterovirus, adenovirus, VHH-6, dengue y otros arbovirus, hepatitis virales
Sarampión	Fiebre alta + tos + coriza + conjuntivitis (las "tres C") , manchas de Koplik, exantema que comienza retroauricular y desciende, confluyente, con descamación fina posterior. Grave en adultos y desnutridos
Rubéola	Exantema más tenue, adenopatías retroauriculares y occipitales , artralgias. Riesgo teratogénico en el embarazo
Escarlatina	Faringitis estreptocócica + exantema micropapular "en lija" , líneas de Pastia , palidez peribucal, lengua aframbuesada , descamación posterior
Sífilis secundaria	Palmas y plantas , no pruriginoso, con adenopatías generalizadas
Rickettsiosis y otras zoonosis	Según exposición

Causa	Claves
Enfermedad de Still del adulto	Exantema evanescente asalmonado coincidente con los peaks febriles, artritis, odinofagia, ferritina muy elevada
Enfermedad de Kawasaki (adulto: raro)	Fiebre $\geq$ 5 días, conjuntivitis no exudativa, cambios en mucosas, exantema, edema de manos y pies, adenopatía cervical
Lupus y otras conectivopatías	Exantema malar, fotosensibilidad

5. Exantema vesiculoso o ampolloso

Causa	Claves
Varicela	Lesiones en distintos estadios simultáneamente , centrípeta, con compromiso de cuero cabelludo y mucosas
Herpes zóster	Dermatómico, unilateral , que no cruza la línea media
VHS diseminado / eccema herpético	Sobre dermatitis previa o en inmunosuprimidos
Viruela símica (mpox)	Lesiones monomorfas (todas en el mismo estadio), con compromiso de palmas, plantas y región anogenital; adenopatías. Contexto epidemiológico y conductas sexuales
Enterovirus (enfermedad mano-pie-boca)	Vesículas en manos, pies y boca; Coxsackie
Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica	Compromiso de mucosas , dolor, Nikolsky positivo
Síndrome de piel escaldada estafilocócica	Descamación superficial, Nikolsky positivo, sin compromiso mucoso
Dermatosis ampollares autoinmunes	Pénfigo, penfigoide: curso crónico
Vibriosis (<i>V. vulnificus</i>)**	Bulas hemorrágicas en el cirrótico tras exposición a agua de mar o mariscos

6. Exantema petequeial o purpúrico

Es la morfología de mayor urgencia. Un exantema que **no blanquea a la vitropresión** en un paciente febril obliga a descartar de inmediato meningococcemia y sepsis.

Causa	Claves
Meningococcemia	Progresión rápida , fiebre alta, compromiso del estado general. Urgencia absoluta
Sepsis por otros agentes con CID	Neumococo (especialmente en asplénicos), <i>S. aureus</i> , gramnegativos, <i>Capnocytophaga</i> tras mordedura en esplenectomizados
Rickettsiosis	Exantema que se hace petequeial, con exposición compatible
Dengue	Trombocitopenia, mialgias intensas, prueba del torniquete positiva, antecedente de viaje
Hantavirus	Trombocitopenia, hemoconcentración, inmunoblastos ; exposición rural
Endocarditis	Petequias conjuntivales y en paladar, lesiones de Janeway
Púrpura trombocitopénica inmune, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome hemolítico urémico	Citopenias, esquistocitos
Vasculitis	Púrpura palpable: vasculitis por IgA, crioglobulinemia (asociada a VHC), vasculitis ANCA
Fármacos	Vasculitis leucocitoclástica por fármacos

7. Exantema con eritrodermia y descamación

Causa	Claves
Síndrome de shock tóxico estafilocócico	Eritrodermia difusa, hipotensión, compromiso multiorgánico, descamación palmoplantar a las 1-2 semanas . Tampones, packing nasal, herida quirúrgica. Hemocultivos habitualmente negativos

Causa	Claves
Síndrome de shock tóxico estreptocócico	Foco de partes blandas, hemocultivos frecuentemente positivos , mortalidad alta
Escarlatina	Faringitis, exantema en lija, descamación
DRESS	Eritrodermia con edema facial, eosinofilia, compromiso de órganos
Psoriasis eritrodérmica, dermatitis exfoliativa	Antecedente dermatológico
Enfermedad injerto contra huésped	Contexto de trasplante

8. Exantema pustuloso

Causa	Claves
Pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA)	Pústulas estériles no foliculares sobre base eritematosa, fiebre, leucocitosis con neutrofilia , 1-5 días tras el fármaco (betalactámicos, macrólidos, antimolécidos). Resolución con descamación
Foliculitis bacteriana o por <i>Pseudomonas</i>	Tina caliente, piscina
Candidiasis diseminada	Inmunosuprimidos, lesiones nodulares
Gonococemia diseminada	Pústulas hemorrágicas escasas en extremidades , tenosinovitis, poliartralgias migratorias
Psoriasis pustulosa	Antecedente

9. Compromiso de palmas y plantas

Es un dato semiológico de alto rendimiento porque **acota mucho el diferencial**:

Las causas clásicas de exantema con compromiso palmoplantar: - **Sífilis secundaria** - **Rickettsiosis** - **Enfermedad mano-pie-boca** (Coxsackie) - **Síndrome de shock tóxico** (descamación palmoplantar tardía) - **Escarlatina** (descamación) - **Endocarditis** (lesiones de Janeway y nódulos de Osler) - **Sarampión atípico** - **Enfermedad de Kawasaki** - **Reacciones a fármacos** - **Viruela símica (mpox)** - **Meningococemia** (en fases avanzadas)

10. Exantemas por fármacos

Son la causa más frecuente de exantema febril en el paciente hospitalizado, y su espectro va de lo banal a lo letal.

Tipo	Características	Gravedad
Exantema maculopapular simple	5-14 días tras el fármaco; pruriginoso, sin compromiso mucoso ni sistémico	Leve: suspender el fármaco y observar
Urticaria y angioedema	Minutos a horas; ronchas migratorias	Riesgo de anafilaxia
DRESS	2-8 semanas tras el fármaco; exantema extenso, edema facial , fiebre, eosinofilia , adenopatías, hepatitis , nefritis, neumonitis. Fármacos clásicos: anticonvulsivantes, alopurinol, sulfas, antituberculosos, vancomicina	Grave ; mortalidad 5-10 %; puede recidivar y dejar secuelas (tiroiditis tardía)
Stevens-Johnson / NET	Compromiso de mucosas , dolor cutáneo, Nikolsky positivo , desprendimiento epidérmico. Fármacos: sulfas, anticonvulsivantes, alopurinol, antiinflamatorios, nevirapina	Muy grave ; mortalidad elevada, sobre todo en NET
PEGA	Pústulas estériles, inicio rápido	Habitualmente benigna
Vasculitis leucocitoclástica	Púrpura palpable en extremidades inferiores	Variable
Exantema fijo medicamentoso	Placa que recurre en el mismo sitio con cada exposición	Leve

Ante cualquier exantema por fármacos, lo primero es suspender el fármaco sospechoso y documentar la reacción con precisión en la ficha, porque de esa descripción dependerá el manejo futuro (ver Alergia a penicilina).

11. Estudio diagnóstico

El estudio se guía por la sospecha, no se pide en bloque.

Nivel	Exámenes
Básico	Hemograma con frotis (eosinofilia -> DRESS o parásitos; linfocitos atípicos -> síndrome mononucleósico; trombocitopenia -> dengue, hantavirus, sepsis, púrpuras), PCR, función renal y hepática, orina completa, coagulación si hay púrpura
Microbiológico	Hemocultivos si hay fiebre alta o gravedad; PCR de la lesión (VVZ, VHS, mpox); cultivo de lesiones pustulosas
Serológico	Según sospecha: VIH (carga viral si se sospecha infección aguda) , VDRL/RPR y prueba treponémica, VEB, CMV, parvovirus B19, hepatitis, dengue, sarampión y rubéola (IgM)
Específico	Ferritina (Still, hemofagocítico), ANA y complemento, crioglobulinas, ANCA
Biopsia cutánea	Ante duda diagnóstica, sospecha de vasculitis, exantema atípico o persistente, o cuadro grave. En SSJ/NET permite confirmar el diagnóstico

12. Aislamiento y notificación

Cuadro	Precauciones	Notificación
Sarampión	Aerosoles	Inmediata ; confirmación en el ISP; búsqueda activa de contactos y vacunación de bloqueo
Varicela / zóster diseminado	Aerosoles + contacto	Según normativa
Rubéola	Gotitas	Inmediata , especialmente por el riesgo de rubéola congénita
Enfermedad meningocócica	Gotitas 24 h	Inmediata + quimioprofilaxis de contactos
Escarlatina / <i>S. pyogenes</i>	Gotitas hasta 24 h de tratamiento	Según contexto (brotes)
Viruela símica (mpox)	Contacto + gotitas , y aerosoles en procedimientos	Según normativa vigente
Dengue, hantavirus, arbovirus	Estándar (hantavirus por virus Andes: contacto y gotitas)	Obligatoria
Sífilis	Estándar	Obligatoria

Verificar el decreto de enfermedades de notificación obligatoria vigente del MINSAL.

13. Errores frecuentes

- **No vitropresionar** el exantema: distinguir petequias de máculas cambia la urgencia. - **Demorar la ceftriaxona** en una sospecha de meningococcemia por esperar exámenes. - **No revisar los fármacos** en un paciente hospitalizado con exantema febril. - **No buscar compromiso de mucosas ni el signo de Nikolsky**, que definen la gravedad. - **No pedir eosinófilos** ni pruebas hepáticas ante sospecha de DRESS. - **No pensar en sífilis secundaria ni en VIH agudo** ante un exantema en un adulto joven. - **No solicitar carga viral de VIH** cuando la serología puede estar en período de ventana. - **No aislar precozmente** una sospecha de sarampión o varicela. - **No notificar** las enfermedades de notificación inmediata. - **Atribuir todo exantema febril a un virus** sin descartar las causas graves.

14. Perlas de alto rendimiento

- **Vitropresión primero**: un exantema que **no blanquea** en un paciente febril es una urgencia.
- **Meningococcemia**: ceftriaxona ya, hemocultivos, aislamiento, notificación y profilaxis de contactos.
- **Compromiso de mucosas + Nikolsky** = Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica.
- **Edema facial + eosinofilia + adenopatías + hepatitis, semanas tras un fármaco** = DRESS.
- **Exantema palmoplantar**: sífilis, rickettsias, mano-pie-boca, shock tóxico, endocarditis, Kawasaki, mpox.
- **Sífilis secundaria**: exantema **no pruriginoso en palmas y plantas** — pedir VDRL.
- **Úlceras mucosas + exantema + fiebre en un adulto joven** = VIH agudo, pedir carga viral.
- **Sarampión**: fiebre alta con las tres C (tos, coriza, conjuntivitis) y **manchas de Koplik** -> aislamiento de aerosoles y notificación inmediata.

- **Varicela:** lesiones en distintos estadios. **Mpox:** lesiones monomorfas.
- **Enfermedad de Still:** exantema evanescente asalmonado con los peaks febriles y ferritina muy elevada.
- **Los fármacos son la causa más frecuente de exantema febril en el hospital:** revisarlos siempre.
- **Ante duda o gravedad, biopsiar.**

15. Bibliografía esencial

- Ely JW, Seabury Stone M. The generalized rash: parts I and II. *Am Fam Physician*. 2010;81:726-34 y 735-9.
- Drago F, Paolino S, Rebora A, et al. The challenge of diagnosing atypical exanthems: a clinico-laboratory study. *J Am Acad Dermatol*. 2012;67:1282-8.
- Duong TA, Valeyrie-Allanore L, Wolkenstein P, Chosidow O. Severe cutaneous adverse reactions to drugs. *Lancet*. 2017;390:1996-2011.
- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for skin and soft tissue infections. *Clin Infect Dis*. 2014;59:e10-e52.
- McMullan BJ, Andresen D, Blyth CC, et al. Antibiotic duration and timing of the switch from intravenous to oral route for bacterial infections in children. *Lancet Infect Dis*. 2016 (para contexto de fiebre y exantema en pediatría).
- Ministerio de Salud de Chile. Normas de vigilancia de sarampión, rubéola y enfermedad meningocócica. Verificar versiones vigentes.